

Endometriose · dor pélvica e infertilidade

Endometriose = endométrio ectópico com inflamação crônica. Dor cíclica refratária e infertilidade são as vias clássicas de prova; tratamento é individualizado.

Clínica clássica

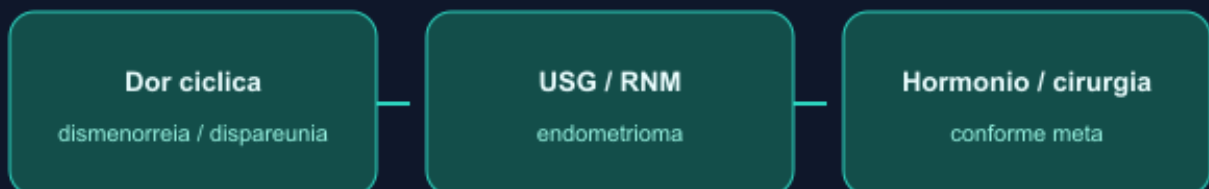
Dica - Clínica clássica

Dismenorreia progressiva, dispareunia profunda, dor à defecação cíclica, infertilidade. Exame: nódulos em fundo de saco, útero fixo, endometrioma.

Diagnóstico clínico-empírico é aceitável; laparoscopia confirma e trata em selecionadas.

Endometriose

Clinica -> imagem -> tratar



Conduta

- 1ª linha dor: AINE + contraceptivo combinado ou progestagênio contínuo
- DIU-LNG e agonistas/antagonistas de GnRH em refratárias
- Endometrioma: USG típico; cirurgia se dor/infertilidade/dúvida neoplásica
- Infertilidade: considerar FIV precocemente em doença avançada

Achados

Método | Papel

USG TV | Endometrioma; sinais indiretos

RNM | Doença profunda / mapeamento

CA-125 | Inespecífico — não diagnóstica

Laparoscopia | Padrão-ouro diagnóstico/terapêutico

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não dependa de CA-125 para diagnosticar endometriose. Cirurgia de endometrioma pode reduzir reserva ovariana — sopesse fertilidade.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Endometriose: dor pélvica cíclica + infertilidade; estágios rAFS/ASRM descrevem extensão anatômica, não intensidade da dor.

Ideia dos estágios de endometriose (extensão anatômica).

Endometriose - estágios (ideia)

ASRM / rAFS simplificado

I-II leve

Implantes focais
aderências finas
pouca anatomia

Minima/leve

III moderada

Implantes múltiplos
endometrioma
aderências

Moderada

IV severa

Doença extensa
aderências densas
anatomia distorcida

Severa

Clínica de alto rendimento

- Dismenorreia progressiva, dispareunia de profundidade, dor à defecação cíclica
- Infertilidade; endometrioma ovariano ('chocolate')
- Exame: nódulos em fundo de saco, útero fixo (pode ser normal)

Estágio "dor"

Lembre - Estágio "dor"

Estágio ASRM mede extensão cirúrgica/anatômica. Dor intensa pode existir em doença mínima — não use estágio só para explicar sintoma.

Conduta-ideia

Objetivo | Linha

Dor sem desejo gestacional imediato | AINE + progestagênio/ACO/DIU-LNG; GnRH em refratários

Infertilidade | Cirurgia selecionada ± reprodução assistida

Endometrioma / dúvida neoplásica | US especializado; cirurgia se indicado

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1